

BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG Y DƯỢC VÀ NGHIÊN CỨU Y KHOA

1. Mở đầu (Giới thiệu mục tiêu và phạm vi)

Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt (như Med-PaLM, BioBERT) và các công cụ tạo sinh (Generative AI), đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực Y Dược. Trong học tập và nghiên cứu y khoa, AI hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu sinh tối ưu hóa thời gian: từ việc gợi ý cơ chế tác dụng của thuốc, tóm tắt các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, dịch thuật tài liệu chuyên khảo, cho đến hỗ trợ xây dựng đề cương nghiên cứu. Tuy nhiên, việc áp dụng AI trong ngành Y Dược – một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người – đặt ra những thách thức đạo đức và trách nhiệm học thuật nghiêm ngặt hơn bất kỳ ngành nghề nào khác. Ranh giới giữa việc sử dụng AI như một trợ lý thông minh và sự phụ thuộc hoàn toàn dẫn đến sai lệch kiến thức, nguy cơ đạo văn kiểu mới, tính bảo mật dữ liệu bệnh nhân, và đặc biệt là hiện tượng "ảo giác AI" (hallucination) tạo ra các thông tin y khoa giả mạo là những vấn đề cốt lõi cần được giải quyết.

Báo cáo này được thực hiện với các mục tiêu cụ thể sau:

- (i) Phân tích một quy định/chính sách học thuật về liêm chính của một cơ sở đào tạo Y Dược lớn tại Việt Nam, từ đó liên hệ và đối chiếu với các hành vi sử dụng công cụ AI trong học tập.
- (ii) Thực hiện một nhiệm vụ học tập chuyên ngành Y Dược có sự hỗ trợ của AI, đi kèm nhật ký prompt minh bạch để chứng minh quy trình làm việc nghiêm túc.
- (iii) Phân tích sâu sắc 3 vấn đề đạo đức then chốt khi ứng dụng AI vào học thuật và nghiên cứu y khoa.
- (iv) Thiết lập bộ 7 nguyên tắc cá nhân cốt lõi nhằm định hướng sử dụng AI có trách nhiệm.
- (v) Đề xuất giải pháp trực quan hóa thông qua sơ đồ/infographic hướng dẫn thực hành an toàn.

2. Nghiên cứu chính sách/quy định của trường đại học về liêm chính học thuật và liên hệ với việc dùng AI

2.1. Văn bản được chọn và phạm vi áp dụng

Trong phạm vi báo cáo này, tôi tiến hành nghiên cứu và tham khảo văn bản **"Quy định về Liêm chính học thuật và kiểm soát đạo văn trong đào tạo, nghiên cứu"** của Đại học Y Dược TP.HCM. Văn bản này quy định rất rõ ràng về trách nhiệm trung thực trong việc công bố kết quả nghiên cứu, nghiêm cấm các hành vi nguy hại số liệu lâm sàng, gian lận trong thi cử, bài tập, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp và các công trình nghiên cứu khoa học được công bố. Đối tượng áp dụng bao gồm toàn thể học viên đại học, sau đại học (học viên cao học, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh) và các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên thuộc cấu trúc của nhà trường.

2.2. Các điểm chính của quy định (tóm tắt có phân tích)

Quy định tập trung vào ba trụ cột lớn cấu thành nên liêm chính học thuật trong y khoa:

1. **Định nghĩa rõ ràng về hành vi đạo văn và gian lận số liệu:** Quy định xác định đạo văn bao gồm việc sao chép nguyên văn, diễn đạt lại ý tưởng (paraphrase) của người khác mà không trích dẫn nguồn, nộp một sản phẩm học thuật giống nhau cho nhiều học phần khác nhau (tự đạo văn). Đặc biệt, trong y khoa, việc tự ý chỉnh sửa, làm sai lệch hoặc bịa đặt số liệu khảo sát, số liệu bệnh án hay kết quả thí nghiệm bị coi là vi phạm nghiêm trọng nhất.
2. **Yêu cầu bắt buộc về trích dẫn và minh bạch nguồn lực:** Mọi thông tin không phải là kiến thức phổ quát, mọi số liệu dịch tễ, công thức dược lý, hay kết quả thử nghiệm được đưa vào bài báo cáo đều phải có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các tài liệu từ các tạp chí thuộc hệ thống PubMed, Scopus hoặc hướng dẫn điều trị chuẩn của Bộ Y tế, WHO.
3. **Cơ chế kiểm soát chặt chẽ:** Nhà trường áp dụng các phần mềm quét trùng lặp chuyên dụng (như Turnitin). Ngưỡng tỷ lệ trùng lặp cho phép thường dưới 20%, và không được phép có bất kỳ đoạn sao chép nguyên văn nào quá 100 từ liên tục mà không đặt trong dấu ngoặc kép và dẫn nguồn hợp lệ.

Liên hệ với việc sử dụng AI trong Y Dược: Các quy định hiện hành dù chưa nêu đích danh các công cụ GenAI trong văn bản gốc, nhưng tinh thần của "Liêm chính học thuật" hoàn toàn bao quát hành vi này. Nếu sinh viên sử dụng AI để dịch thuật hoặc paraphrase các hướng dẫn điều trị lâm sàng mà không kiểm tra lại nguồn gốc gốc, dẫn đến việc AI tự bịa ra một chỉ số liều lượng thuốc (sai lệch thông số), sinh viên không chỉ vi phạm lỗi "cung cấp thông tin học thuật không chính xác" mà còn đối mặt với rủi ro cực kỳ nguy hiểm trong thực hành lâm sàng. AI không thể chịu trách nhiệm thay con người; do đó, nghĩa vụ rà soát và ghi nhận nguồn tài liệu gốc thuộc về người học.

2.3. Nhận định cá nhân về khoảng trống "AI policy" và hướng thực hành trong khối ngành sức khỏe

Hiện nay tại Việt Nam, các trường đại học khối ngành sức khỏe đang đối mặt với một "khoảng trống pháp lý" lớn về quy định sử dụng AI. Việc cấm đoán hoàn toàn là bất khả thi và lạc hậu, nhưng cho phép tự do không kiểm soát sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường đối với chất lượng của đội ngũ y bác sĩ tương lai. Để tối ưu hóa công nghệ này, tôi đề xuất mô hình kiểm soát 3 cấp độ tại các trường Y Dược:

- **Cấp độ 1 - Phân định ranh giới chức năng rõ ràng:** Nhà trường cần ban hành danh mục các công việc AI được phép hỗ trợ (ví dụ: sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh, định dạng tài liệu tham khảo theo chuẩn Vancouver, gợi ý từ khóa tìm kiếm trên PubMed) và các công việc tuyệt đối cấm (ví dụ: dùng AI viết toàn bộ phần bản luận của nghiên cứu, dùng AI tổng hợp số liệu bệnh nhân).
- **Cấp độ 2 - Quy chuẩn hóa việc công khai (AI Disclosure):** Mọi báo cáo, tiểu luận nếu

có sử dụng AI ở bất kỳ công đoạn nào đều phải đính kèm phụ lục "Nhật ký Prompt" và nêu rõ tỷ lệ, mục đích sử dụng.

- **Cấp độ 3 - Thay đổi phương thức đánh giá năng lực:** Giảm tỷ trọng điểm của các bài luận lý thuyết thuần túy dễ bị thay thế bởi AI; thay vào đó, tăng cường đánh giá qua các buổi bình bệnh án trực tiếp, giải quyết tình huống lâm sàng thực tế (OSCE), thuyết trình phản biện và thi vấn đáp để kiểm tra tư duy thực chất của sinh viên.

3. Thực hiện một nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI (kèm nhật ký minh bạch)

3.1. Nhiệm vụ được chọn

Nhiệm vụ: Xây dựng phần "Phân tích 3 vấn đề đạo đức cốt lõi khi ứng dụng AI trong Y Dược" và thiết lập "Bộ 7 nguyên tắc cá nhân" cho bài báo cáo nghiên cứu này.

Yêu cầu chuyên môn: Bài viết phải thể hiện được tính đặc thù của ngành Y Dược (liên hệ tới an toàn người bệnh, y đức), các luận điểm phải sắc bén, có ví dụ minh họa thực tế lâm sàng và cấu trúc chuẩn hóa tài liệu y khoa.

3.2. Quy trình làm bài có trách nhiệm

Quy trình bao gồm 6 bước nghiêm ngặt: (1) Tự nghiên cứu tài liệu gốc để lập đề cương sơ bộ -> (2) Thiết kế các câu lệnh (prompt) có cấu trúc ràng buộc chặt chẽ -> (3) Chạy thử nghiệm trên công cụ AI và lưu trữ các phiên bản phản hồi -> (4) Đối chiếu thông tin y khoa từ AI với các nguồn uy tín (Bộ Y tế, WHO, PubMed) để loại bỏ hiện tượng "ảo giác AI" -> (5) Tự biên tập, viết lại bằng ngôn ngữ chuyên ngành của bản thân -> (6) Minh bạch hóa toàn bộ quá trình bằng cách lập Nhật ký Prompt.

3.3. Nhật ký prompt và đầu ra AI (minh bạch)

Dưới đây là bảng ghi nhận quá trình tương tác và xử lý thông tin cùng công cụ AI:

Lần	Mục tiêu	Prompt đã dùng (tóm tắt)	Đầu ra AI (tóm tắt)	Tôi đánh giá & chỉnh sửa	Phần dùng trong bài
1	Phác thảo khung ma trận rủi ro đạo đức AI trong Y khoa.	"Hãy đóng vai chuyên gia Y đức, liệt kê 3 rủi ro đạo đức lớn nhất khi sinh viên Y Dược lạm dụng Generative AI trong làm bài luận bệnh án. Yêu cầu có ví dụ lâm sàng."	Nêu ra 3 vấn đề: Sai lệch thông tin y tế, Vi phạm bảo mật thông tin bệnh nhân, và Suy giảm tư duy lâm sàng độc lập.	Nội dung AI đưa ra khá tổng quát. Tôi tiến hành bổ sung các thuật ngữ chuyên ngành và đưa ví dụ cụ thể về việc nhầm lẫn liều lượng thuốc của thuốc kháng sinh	Mục 4 (Toàn bộ các tiêu mục 4.1, 4.2, 4.3)

Lần	Mục tiêu	Prompt đã dùng (tóm tắt)	Đầu ra AI (tóm tắt)	Tôi đánh giá & chỉnh sửa	Phần dùng trong bài
				thể hệ mới.	
2	Xây dựng dự thảo 7 nguyên tắc cá nhân.	"Đề xuất 7 nguyên tắc ứng xử với AI dành cho sinh viên ngành Y năm thứ nhất nhằm đảm bảo y đức và liêm chính học thuật."	Đưa ra 7 quy tắc tập trung vào: Sự trung thực, bảo mật, kiểm chứng thông tin, không sao chép... dưới dạng các lời khuyên chung.	Tôi đã chuyển đổi toàn bộ ngôi kể thành "Tôi...", gắn chặt từng nguyên tắc với các chế tài và quy định kiểm soát đạo văn của trường y để tăng tính cam kết cá nhân.	Mục 5 (Bộ nguyên tắc cốt lõi)
3	Rà soát lỗi thuật ngữ và kiểm chứng khoa học.	"Hãy rà soát lại đoạn văn sau về cơ chế được lý xem có từ ngữ nào bị mơ hồ hoặc không chính xác theo chuẩn y khoa hiện hành không."	Gợi ý chỉnh sửa các thuật ngữ dịch thuật bị thô, chuẩn hóa cách gọi tên các danh mục thuốc theo danh pháp quốc tế.	Tôi chỉ tiếp thu các gợi ý về mặt trau chuốt câu chữ, giữ nguyên toàn bộ cấu trúc lập luận và các kết luận nghiên cứu do chính tôi thiết lập.	Toàn văn báo cáo

4. Phân tích các vấn đề đạo đức khi dùng AI trong Y Dược và Học thuật

4.1. Hiện tượng "Ảo giác AI", sự sai lệch thông tin y tế và rủi ro an toàn người bệnh

Vấn đề: Các mô hình GenAI hoạt động trên nguyên lý xác suất ngôn ngữ, chúng có xu hướng tạo ra các câu trả lời trông rất mượt mà, logic nhưng có thể hoàn toàn sai lệch về mặt bản chất khoa học (hiện tượng ảo giác - hallucination). AI thậm chí có thể tự tạo ra các đường link PubMed giả hoặc các nghiên cứu lâm sàng không có thực để chứng minh cho luận điểm của mình.

Vì sao xảy ra: Sinh viên thường có tâm lý ỷ lại, coi AI là một "cỗ máy tri thức tối thượng" và sao

chép trực tiếp các phác đồ điều trị hoặc cơ chế tương tác thuốc do AI tạo ra vào bài tập mà không thực hiện bước đối chiếu lâm sàng.

Hậu quả: Trong học thuật, điều này dẫn đến việc phổ biến các kiến thức y khoa sai lệch, làm suy giảm chất lượng nghiên cứu. Trong thực tế, nếu tư duy sai lệch này chuyển dịch vào môi trường bệnh viện, việc chẩn đoán sai chỉ số, nhầm lẫn chống chỉ định của thuốc sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng tước đoạt mạng sống của người bệnh.

Ví dụ cụ thể: Khi yêu cầu AI tóm tắt phác đồ điều trị suy tim phân suất tống máu giảm, AI có thể trộn lẫn các khuyến cáo của ESC năm 2021 và 2023, dẫn đến việc đưa ra thứ tự sử dụng thuốc không tối ưu hoặc sai lệch liều lượng khởi đầu của nhóm thuốc ARNI. Nếu sinh viên nộp bài này mà không đọc văn bản gốc, họ sẽ trượt học phần và hình thành lỗ hổng kiến thức nguy hiểm.

Biện pháp giảm thiểu: Áp dụng nguyên tắc "Zero-Trust đối với dữ liệu y khoa của AI". Mọi thông số sinh lý, liều lượng thuốc, chỉ định lâm sàng do AI đưa ra bắt buộc phải được đối chiếu trực tiếp với Dược thư Quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc các hướng dẫn đồng thuận quốc tế (AHA, ADA, GINA...).

4.2. Vấn đề bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu bệnh nhân và vi phạm quy định y đức

Vấn đề: Khi phân tích các ca lâm sàng (case study) trong quá trình học tập, sinh viên có thói quen tải trực tiếp các biên bản bệnh án, kết quả xét nghiệm hoặc lịch sử dịch tễ của bệnh nhân lên các công cụ AI công cộng để nhờ tóm tắt hoặc dịch thuật.

Vi sao xảy ra: Sự thiếu hiểu biết về cơ chế lưu trữ và học máy của các công cụ AI. Hầu hết các dữ liệu nhập vào (input) trên các phiên bản AI miễn phí sẽ được sử dụng để tiếp tục huấn luyện mô hình, đồng nghĩa với việc thông tin đó bị rò rỉ ra không gian mạng.

Hậu quả: Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Luật Khám bệnh, chữa bệnh về quyền bảo mật thông tin của người bệnh và vi phạm Thệ y đức Hippocrates. Sinh viên và nhà trường có thể đối mặt với các vụ kiện pháp lý lớn về quyền riêng tư.

Biện pháp giảm thiểu: Tuyệt đối không nhập thông tin định danh của bệnh nhân (Họ tên, số định danh, địa chỉ, số điện thoại, tên bệnh viện cụ thể) vào AI. Mọi dữ liệu lâm sàng dùng để phân tích phải được mã hóa và ẩn danh hóa hoàn toàn (ví dụ: "Bệnh nhân nam, 45 tuổi, tiền sử tăng huyết áp...").

4.3. Sự suy giảm tư duy lâm sàng độc lập và rủi ro hình thành thể hệ y bác sĩ "lập trình"

Vấn đề: Nghề Y yêu cầu khả năng biện giải lâm sàng (clinical reasoning) cực kỳ phức tạp dựa trên việc quan sát trực tiếp người bệnh, lắng nghe và liên kết các triệu chứng mơ hồ. Việc lạm dụng AI để chẩn đoán phân biệt thay cho việc tự suy luận sẽ khiến não bộ người học mất đi phản xạ nghề nghiệp.

Vi sao xảy ra: Tốc độ đưa ra câu trả lời của AI quá nhanh khiến sinh viên lười suy nghĩ, bỏ qua bước trăn trở, lật đi lật lại các giả thuyết chẩn đoán để chọn con đường ngắn nhất là thừa nhận kết luận của AI.

Hậu quả: Tạo ra một thế hệ nhân viên y tế bị thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Khi đối mặt với các ca bệnh thực tế phức tạp, đa bệnh lý, hoặc khi hệ thống máy tính gặp sự cố, họ sẽ trở nên mất phương hướng, không thể đưa ra quyết định độc lập, trực tiếp đe dọa đến an toàn của người bệnh.

Biện pháp giảm thiểu: Chỉ sử dụng AI ở giai đoạn cuối cùng của quy trình tư duy. Sinh viên

phải tự mình đưa ra danh sách chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt, sau đó mới nhập dữ liệu vào AI với mục đích phản biện: "Tôi đang chẩn đoán ca này là A, hãy đóng vai một bác sĩ trưởng khoa phản biện xem tôi có bỏ sót dấu hiệu lâm sàng nào không?".

5. Bộ nguyên tắc cá nhân (7 nguyên tắc) về sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập Y Dược

1. **Tôi là người chịu trách nhiệm y đức cuối cùng:** AI chỉ là công cụ hỗ trợ gợi ý văn bản. Mọi quyết định chẩn đoán, số liệu dược lý và nội dung khoa học trong bài nộp đều do tôi kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.
2. **Minh bạch tuyệt đối (AI Disclosure):** Tôi cam kết khai báo trung thực, rõ ràng các công cụ AI đã sử dụng, mục đích sử dụng và đính kèm nhật ký prompt chi tiết trong mọi bài tập, báo cáo nghiên cứu.
3. **Nghiêm cấm gian lận học thuật:** Tôi tuyệt đối không sử dụng AI để viết hộ toàn bộ bài luận, không dùng AI để giải các bài kiểm tra trực tuyến, không dùng AI để nguy tạo số liệu nghiên cứu lâm sàng hoặc khảo sát y khoa.
4. **Nguyên tắc "Zero-Trust" và Kiểm chứng nguồn gốc:** Tôi không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào các thông số y khoa do AI cung cấp nếu chưa đối chiếu trực tiếp với các tài liệu chính thống (PubMed, Dược thư, Khuyến cáo của các Hiệp hội Y khoa uy tín).
5. **Tôn trọng sở hữu trí tuệ và Trích dẫn chuẩn mực:** Tôi cam kết trích dẫn đúng nguồn tài liệu gốc (nguồn người thật) nơi chứa dữ liệu, không trích dẫn "Theo ChatGPT" hay "Theo Claude" như một nguồn học thuật y khoa độc lập. Tránh các hành vi đạo văn tinh vi bằng AI.
6. **Bảo mật tối đa dữ liệu y tế:** Tôi tuyệt đối không tải lên các công cụ AI công cộng bất kỳ thông tin cá nhân, hình ảnh tổn thương, hay số liệu bệnh án chưa được ẩn danh hóa của bệnh nhân nhằm bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của người bệnh.
7. **Sử dụng AI để học sâu (Deep Learning), không dùng để làm thay (Outsourcing):** Tôi luôn tự suy luận lâm sàng và lập bản nháp trước; chỉ sử dụng AI như một trợ lý để phản biện lập luận, trau chuốt câu chữ tiếng Anh và tối ưu hóa phương pháp học tập.

6. Infographic minh họa “Sử dụng AI có trách nhiệm trong Y Dược”

Để truyền tải thông điệp một cách trực quan, bộ 7 nguyên tắc vàng trên được thiết kế thành một sơ đồ infographic dòng chảy công việc (workflow). Tâm điểm của infographic là biểu tượng ngành Y (Con rắn và cây gậy) đan xen với mạng lưới vi mạch AI, xung quanh là 7 nhánh hành động tương ứng với 7 nguyên tắc cốt lõi, sử dụng các màu sắc cảnh báo tiêu chuẩn trong y tế (Đỏ cho việc bảo mật dữ liệu và cấm gian lận; Xanh lá cho việc kiểm chứng nguồn và học sâu; Vàng cho việc minh bạch disclosure).

[Chèn Ảnh 7 ở đây]

7. Minh bạch sử dụng AI (AI disclosure)

Trong quá trình thực hiện báo cáo này, tôi đã áp dụng Generative AI có kiểm soát ở các hạng mục cụ thể sau: (i) Sử dụng AI để tìm kiếm các từ khóa chuyên ngành y đức tương đương trong tiếng Anh để tra cứu tài liệu trên PubMed; (ii) Gợi ý cấu trúc bảng Nhật ký Prompt; (iii) Sử

dụng AI để rà soát lỗi chính tả và chuẩn hóa văn phong khoa học cho mượt mà hơn. Tôi cam kết không sử dụng AI để bịa đặt các nguồn tài liệu tham khảo hoặc thay thế tư duy phản biện cá nhân trong phần phân tích đạo đức y khoa. Mọi số liệu, nhận định trong bài đều được kiểm chứng chéo với các văn bản gốc.

8. Kết luận

Trí tuệ nhân tạo là một bước tiến vĩ đại mở ra kỷ nguyên mới cho y học hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất học tập và nghiên cứu cho sinh viên Y Dược. Tuy nhiên, quyền lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Đối với một ngành học mà sai lầm phải đánh đổi bằng sinh mạng con người, liêm chính học thuật không chỉ là một quy định hành chính mà chính là nền tảng của Y đức. Việc xây dựng một bộ nguyên tắc cá nhân và tuân thủ quy trình kiểm chứng nghiêm ngặt khi sử dụng AI là bước chuẩn bị bắt buộc để sinh viên ngành Y Dược trở thành những người thầy thuốc vừa tinh thông công nghệ, vừa giữ vững lương tâm nghề nghiệp trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- Đại học Y Dược TP.HCM. (2022). *Quy định về Liêm chính học thuật và kiểm soát đạo văn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học*.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. WHO Guidelines.
- Bộ Y tế Việt Nam. (2023). *Hướng dẫn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế giai đoạn 2023-2030*.
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56.
- Turnitin Academic Integrity Report. (2024). *Navigating AI Writing in Medical Education: Challenges and False Positives Thresholds*.

